

⇒신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 파랑
- 강조: 빨간색 밑줄
- 말없이 지나간 부분 OR 교과서 내용: 회색
- 이번주차는 인강으로 진행되었습니다.
- 내용상 10주차(이비안 특강한날)에서 이어지는 내용입니다.

[2] 정신사회적 치료

5. 행동요법- 反정신주의의 입장표명

자연과학의 일부로 봐서 객관심리학이라고 한다.

- J. B. Watson
- “심리학은 자연과학의 순수한 객관적 실험적인 일부분이다. 이론상의 목표는 행동을 예언하고 조절하는 일이다” 라고 말하고, 관찰하여 객관화할 수 있는 행동을 대상으로 한 객관심리학을 제창.
- 치료원리는 학습이론에 근간
- 인간이나 동물의 행동은 일정한 법칙에 따라서 학습된 것이다.
- 그 행동이 부적응적으로 되었을 때 증상으로 나타난다. 즉, 증상은 잘못된 학습의 산물 → 학습을 바로잡아주면 된다!
- 치료목표 : 학습의 제원리를 응용하여 증상이라고 하는 부적응 행동을 감약 소거해서 바람직한 행동을 새로이 학습시켜가는 것
- 실험적 사실에 기본을 두고 있음

1) 억제지 요법

여기서부터 행동요법의 종류 6개

① 계통적 탈감작법 (경자평지요법에 나옴. 공포증에 많이 쓴다.)

- 가장 널리 쓰이는 기본적인 방법
- 뱀을 지나치게 무서워하는 사람에겐 그보다 덜 무서운 것부터, 예로서 뱀을 상상하는 것부터 시작해서 조금씩 실제 뱀으로 접근시키는 방법.

㉠ 긴장이완훈련 → ㉡ 불안요인의 위계작성 → ㉢ 탈감작법 의 3단계

- 공포증 환자에게 특히 유효. 강박신경증, 성도착증에도 적용

최근에는 마인드풀네스라도 결부해서 사용

② 단행훈련

- 대인관계에 있어서 당연한 권리를 주장하지 못하거나, 성난 것을 표현하지 못하면, 정신위생상 좋지 못하다 → 이때 이용하게 되는 치료법.
- 단행행동이 어려울 때 심리극이라 하여 치료자가 직장 상사 역할을 하여 가정의 연극을 해보기도 한다.

2) 홍수법 및 내폭법 (계통적 탈감작법과 대비)

재트라우마 시키는 방법이라 요즘은 지양하고 있는 방법

- 공포증 환자에게 단계적으로 훈련시키는 게 아니고 고층옥상에 데리고 올라가서 이때 오는 공포나 불안을 피하지 말고 그대로 견디게 하는 방법.

3) 혐오요법

- Pavlov식 혐오요법 : 병적 행동을 없애기 위해서는 그것을 유발하는 자극이 생길 때마다 불쾌한 자극을 줌으로써 처음 자극이 생기지 않게 하는 방법이다.

예) 담배피고 싶은 때 불쾌감 주는 자극과 연결해 충동이 들지 않게 함

- 조작적 혐오요법은 병적 행동이 일어났을 때 전기자극 등을 처벌로서 주는 방법. 역시 요즘에는 잘 사용하지 않는다.

4) 모형화

- 다른 사람이 하는 것을 지켜봄으로써 공포증을 없애는 방법.

예) 뱀을 무서워하는 환자에게 처음엔 멀리서 다른 사람(모델로서의 역할)이 아무 위험 없이, 오히려 즐겁게 뱀을 만지고 있는 것을 보게 함으로써 차차 공포증을 극복시키는 방법

행동요법은 최근에는 많이 사용하지 않고, 리소스 등으로 감당할 수 있는 능력을 키워주고, 마음챙김을 도입해 단계적으로 안전망을 형성해나간다.

5) 조작적 조건화방법

- 이 방법의 핵심적 개념은 모든 행동은 그 행동이 초래하는 결과에 의하여 얼마간 결정될 수 있다는 것이다.
- 하나의 행동반응에 뒤따라서 일반적으로 포상적 사건이 초래될 경우에는 동일한

환경적 상황에서 이러한 행동은 강화되고 빈번해진다. → 긍정적 강화

- 반대로 하나의 반응에 뒤따라서 혐오적 자극이 초래되거나 혹은 아무런 자극 없을 경우 그 행동은 동일 상황에서 약화되거나 덜 빈번해진다.

6) 바이오피드백 ★출제예고★

- 바이오피드백은 정상적으로 깨달을 수 없고 마음대로 조절할 수 없다고 알려진 정신생리적 반응을 알 수 있도록 기구를 사용하는 것이다.
- 피부온도, 피부저항도, 호흡, 혈압, 심박수 등의 자율신경계 기능과 근육긴장도, 뇌파 유형을 즉각적으로 측정하여 개인에게 알려줌으로써 스스로 정신신체상태를 알아 조절할 수 있게 만들어준다.

생기능 자기조절 훈련 =바이오피드백

- **피부온도, 피부전기저항도, 호흡, 혈압, 심박동수** 등의 자율신경계의 기능과 **근육긴장도**, 그리고 **뇌파 유형**을 즉각적으로 측정하여 알려줌으로써 스스로 정신신체 상태를 알아 조절하는 훈련
- 자율적이고 무의식적으로 작용하는 자율신경계와 뇌파 활동은 생기능 자기조절훈련으로 **의식적으로 조절될 수 있음**

- Biofeedback, Neurofeedback, EEG biofeedback, Neurotherapy
- 신경치료 Neurotherapy: ADHD, 간질, 우울, PTSD등 연구 진행 중
- 수행력 향상: 스포츠 등.

- 신의료기술로 신청 및 결정 (신청자: 강형원(...))

“생기능자기조절훈련”

“한방의료행위전문평가위원회”(2008.12.16. 개최)에 “비급여”로 심의.결정
현재까지 어떤 공식적인 사유없이 보건복지부 고시가 미뤄지고 있는 상태

- Neurofeedback: 뇌파측정장치가 사용자의 뇌에서 발생하는 뇌파의 정보를 사용자에게 알려줌으로써 원하는 방향으로 뇌가 뇌파를 발생하게 유도하는 기술
- 뇌파는 정신상태를 반영하고, 질환, 증상의 특징을 보여준다.

바이오 피드백	뉴로 피드백
• 자율신경계의 기능을 측정 • 말초체표온도, 피부전기반응, 심박동, 호흡, 호흡성 동성부정맥, 근전도 • 궤증, 위증, 화병, 울증, 허로, 기울증, 경계정충, 주상증, 심신증, 두통	• EEG 바이오피드백, 뇌파의 주파수와 진폭을 측정 • Delta, Low theta, High theta, Low alpha, High alpha, SMR, Beta, Gamma • 소아객오, 오지증, 전간, 경풍, 유뇨증, 소아다동증(ADHD)

- 한방정신치료 중 기공요법, 자율훈련요법의 한 방법으로 응용

6. 인지행동상담

우울증 수업했을 때 나왔다.

- 인지행동적 상담이론의 종류

1) 인지적 재구성에 초점을 둔 이론

: 사람들의 생각내용과 방식을 재구성. 즉, 인지를 재 구성함으로써 정서적 문제를 해결하고 변화시키고자 한다. **다른 선택지들이 있다는 것을 알려주는 것**

2) 대처기술의 직접적인 교육과 훈련을 강조하는 이론

: 상황에 적절한 대처행동을 가르치고 훈련시킴으로써 부적응을 해소하려 한다.

3) 문제해결적 접근

: 내담자들이 겪는 부적응 해소를 위해 인지적 재구성과 대처기술훈련을 복합적으로 사용.

: 문제 장면에서 보다 적절한 행동을 할 수 있도록 구체적인 대처행동을 훈련 + 문제를 스스로 해결할 수 있도록 인지의 내용과 방식을 변화시키는 과정을 포함한다.

인지치료 행동치료 다음으로 나오는 2세대 치료

- 정신병리적 증상의 원인이 되는 **자동적 사고** 및 **전형적인 인지왜곡을 확인**하고 그 기저에 있는 **개인의 신념을 변화**시키는데 초점

개인의 신념을 형성하는 인지왜곡을 맵이라고 하는데, 아이가 태어나면 아무것도 모르다가 나도 모르게 관념, 생각, 세상을 바라보는 시각 등이 탑재된다. (부모의 태도, 사회적, 환경적 영향으로)
내가 세상을 바라보는 네비게이션이 업데이트가 안 되어 한가지 오래된 길만 알려주는 느낌
=> 이를 업데이트 시켜주는 것이 인지치료!

<인지적 모델>

- A. Ellis의 합리적 정서치료(RET: rational-emotive therapy)
- A. Beck의 인지치료

인지, 정서, 행동을 연관시킴.

인지적 결정론 = 인지의 우선성

감정이나 행동은 사람들이 생각하는 방식이나 내용에 결정된다고 보는 입장

예) 실직이라는 같은 선행사건에 대해 어떤 사람은 자포자기하는 반면, 어떤 사람은 낙담하지만 새로운 기술을 익히고 직업훈련을 다짐.

=>가지고 있는 신념이 중요하다

A. Beck의 인지치료

1) 인지에 대한 4가지 수준 : 자동적 사고, 중간믿음, 핵심 믿음, 스키마

① 자동적 사고(automatic thought)

: 어떤 상황에 처하면, 그 상황을 순간적으로 평가하면서 자동적으로 튀어나오는 생각

-흔히 당위성(“~해야 해”와 같은)을 가진 말로 표현

-당위성을 거의 입 밖에 내지 않고, 그 대신 당위의 결과인 불평, 꾸중, 비난을 드러낸다

② 중간믿음

: 태도(attitude)나 규칙(rule) 그리고 가정(assumption)들로 구성

③ 핵심믿음

: 자신과 다른 사람들, 그리고 세상에 대한 믿음.

: 가장 근원적인 수준의 믿음. 모든 영역에 영향 미치고 경직되어 있으며 지나치게 일반화

: 무능함과 연관된 핵심믿음 및 사랑 받을 수 없다는 생각과 연관된 핵심믿음의 두 가지로 분류

나도 모르게 불편감을 느끼는 부분이나 정신적 문제들이 핵심믿음 때문에 생기는 경우가 많다.

핵심믿음은 알기 어려운데 영화 인셉션에서 핵심믿음을 꿈에서 바꾸는데 이것이 실제 현실에서 영향을 준다. 핵심믿음에 접근하는 것이 정말 쉽지 않고 깊숙이 숨겨져있다.

④ 스키마

: 정신내의 인지구조

: 자신, 세계, 미래를 보는 개인의 특유하고 습관적인 방식

2) 상담과정

- 내담자가 호소하는 심리적 문제를 구체화하여, 내담자와 상의하여 **상담목표**를 정한다.
- 심리적 문제가 인지적 요인과 관련 있음을 내담자가 납득할 수 있도록 **인지치료의 기본 원리**를 설득력 있게 설명한다.
- 내담자의 현재 삶에서 심리적 문제를 불러일으키는 **환경적 자극과 자동적 사고**를 내담자와 함께 탐색하고 조사한다.
- 환경적 자극에 대한 내담자의 해석 내용, 즉 **자동적 사고의 현실적 타당성**을 따져 본다.
- 환경적 자극에 대한 보다 객관적이고 타당한 **대안적 해석**을 탐색해 보고 이를 기존의 부정적인 자동적 사고와 대치한다.
- 환경적 자극을 왜곡되게 지각하도록 만드는 보다 근원적인 **역기능적 인지도식**의 내용들을 탐색하여 확인한다.
- 역기능적 인지 도식 내용을 **현실성, 합리성, 유용성 측면에서 검토**한다.
- 더욱 현실적이고 **합리적인 대안적 인지를 탐색하여 내면화**할 수 있도록 유도한다.

전형적인 인지적 왜곡

• **당위성** : ‘반드시 ~해야만 한다’

인생에 있어서 “반드시”는 없다. ‘내가 틀릴수도 있습니다’ 라는 책 추천~

I. 자신에 대한 당위성 (I must)

II. 타인에 대한 당위성 (Others must)

III. 조건에 대한 당위성 (Conditions must)

• **과장적 사고(Awfuliing)** : 사건에 대하여 극단적이고 과장적인 부정적 평가

• **합리적 사고와 비합리적 사고의 구분을 위한 기준**

- **유통성** = 경직성 / 요구성(demandingness)

: 절대적이고 경직되어 있는 요구성. ‘반드시 ~해야만 한다’, ‘반드시 ~해서는 안 된다’

- **현실성** = 검증가능성(verifiability)

: 현실적으로 실현하는 것이 불가능함

- **기능적 유용성** = 실용성(pragmatic function)

: 현실을 행복하게 사는데 얼마나 도움이 되는지

- 논리적 일치성(logical consistency)
- 정서적/행동적 결과로 드러나는 파급효과
- : 합리적 생각은 우울, 불안, 수치심, 죄책감과 같은 문제정서를 유발하지 않는다

- **임의적 추론** : 증거가 없거나 결론과 반대되는 증거가 있음에도 불구하고, 특정한 결론을 무리하게 내리는 오류
- **선택적 추상화** : 맥락에서 벗어나는 한 가지 작은 부분적 특징에 의해 전체를 설명하는 오류
- **과잉일반화** : 한두 차례의 경험이나 증거에 비추어 결론 친구가 카톡 한시간 안 읽는다고 재가 나 싫어하는구나 하는 것
- **이분법적 사고(흑백논리)** : 양극단의 어느 하나로 결론
- **과장과 축소** : 주로 자신의 장점이나, 타인의 문제점을 최소화, 자신의 실수, 결점, 타인의 장점을 최대화
- **인간 비하적 사고** : 인간에 대한 일반화된 평가나 파괴적 평가
- **좌절에 대한 낮은 인내심** : 사건의 불편을 인내하기 위한 각 개인의 지각된 무능력

7. 인간중심치료 ★출제예고★

뇌피셜로 오른쪽 빈출문제 나온 것 같습니다.

칼로저스 Carl Rogers

- 1902년 출생. 보수적인 기독교 가정
 - 1922년 20세. 북경 세계기독교학생연합회 참석. 자신 인생관과 신앙 변화 역사가, 목회자
 - 1924년 위스콘신대학 졸업. 뉴욕연합신학대학 입학, 콜롬비아대학으로 전환. 심리학
 - 1931년 콜롬비아 임상심리전공 박사학위 취득. 아동센터에서 심리학자로 일함. 자신만의 치료방법 개발. 행동주의와 실험심리학 위주의 미국심리학회 환멸.
 - 1937년 미국응용심리학회 활동. 로저스 관심은 실험실의 '쥐'가 아닌 '진짜 사람'
 - 1968년 캘리포니아의 라 호야에 인간연구센터Center for studies of th Person 설립
- 자신의 치료에 대한 효과를 과학적으로 증명하려고 애씀.
로저스의 치료 이론은 기존의 정신분석보다 훨씬 쉽고, 행동주의 접근보다는 인간적이어서 많은 사람들의 호응.

- 비판 : 통제집단이 없다거나.. 측정에 문제가 있다는 비판
- 정신분석과 행동주의에 이어 인간주의라는 심리학 큰 흐름을 탄생시킨 위대한 심리학자

인간중심치료 Person- centered therapy ★빈출★

치료의 중심은 치료자나 내담자가 아닌 인간

1. 무조건적 긍정적 존중 Unconditional positive regard
2. 공감적 이해 Empathic understanding
3. 솔직성 Genuineness

인간중심 치료의 과정

- 내담자가 자기 실현을 할 수 있도록 아무런 조건 없이 긍정적인 존중을 해주는 것. 내담자의 자기 실현을 막고 있는 긍정적 존중의 욕구를 채워주어야 내담자가 유기체적 평가 과정을 발휘하면서 진정 자신이 원하는, 자신이 가장 행복할 수 있는 삶을 살 수 있다.
- 한 개인의 경험이나 행동을 이해하는 과정에서 주관적 경험을 중시하는 현상학적 접근
- 공감적 이해 : 내담자의 입장에서 내담자를 볼때 제대로 이해할수 있다.
- 상담자는 내담자에게 생각과 감정을 진실하고 솔직하게 드러낼수 있어야.
- 위협, 협박, 정죄 판단 아닌 상대에 대한 마음을 솔직하게 드러내는 것.
- 상담자의 솔직성은 내담자를 성장시키고 더 나아가 사회의 구성원으로 살아가도록 도와준다.

정신장애의 발생

- 인간은 모두 독특한 개성과 상당한 잠재력을 가진 존재로 태어나며, 원래 자기의 모습대로 살고자 하는 자기 실현의 경향성이 있다. 본래 생명을 가진 유기체는 자신의 인생을 살아갈 능력을 가지고 태어난다.
- 이를 위해 유기체는 자신의 경험을 평가하는 **유기체적 평가 과정**(Organismic valuing process) 사용한다. 누구나 자신의 경험을 스스로 평가하면서 자기실현을 이루어간다.

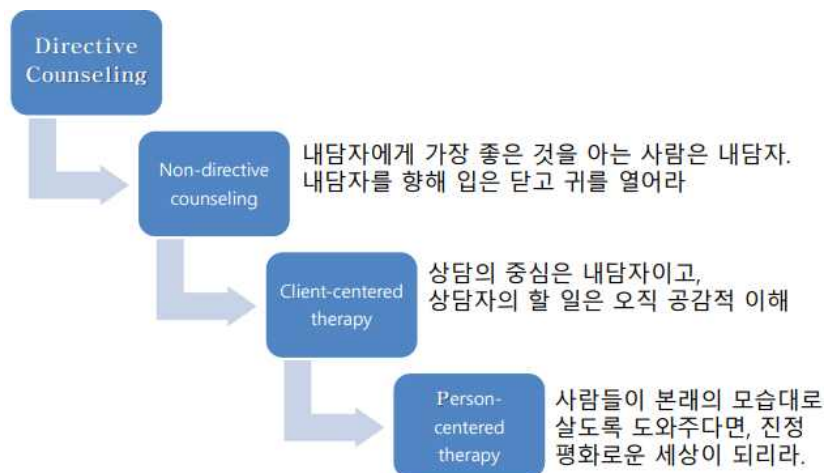
▶ 현실은?

자기실현은 커녕 부모나 사회가 제시하는 여러 조건을 충족시키기 위해 진정한 자기가 되는 것을 포기하는 사람들이 대부분.

▶ 왜 그럴까?

긍정적 존중에 대한 욕구(need for positive regard)의 좌절이 질병을 일으킨다.
'자기가 원하는 진정한 자신의 삶'과 '조건적인 현실' 사이의 괴리. 자기와 경험의 불일치를 경험 ⇒ 이 불일치는 불안 유발

칼로저스 이론의 명칭변화



지시적 상담 -> 비지시적 상담 -> 내담자 중심의 상담 -> 인간중심 상담

8. 수용중심 치료법 acceptance-based treatment

-인지행동치료 제 3동향- 인지치료에 마음챙김을 도입하기 시작함!!

- 변증법적 행동치료(Dialectical Behavior Therapy; DBT)
- 함수분석 심리치료(Functional Analysis psychotherapy)
- 통합적 부부행동치료(Integrative Behavior Couple Therapy; IBCT)
- **알아차림 인지치료(Mindfulness-Based Cognitive Therapy; MBCT)**
- **수용전념치료(Acceptance & Commitment Therapy; ACT)**
- 알아차림을 활용한 중독치료법
- 수용과 알아차림 기법을 활용한 범불안장애 치료
- 정서나 인지의 직접적인 변화보다는 **사적 경험(private experience)의 수용이라는 맥락의 변화**를 도모한다.

수용하는 것이 포인트! 이로 인해 에너지소모가 줄어든다.

• 두가지 인지치료 전략

① 대안적인 도식을 만들어 입력시키는 방법

: 명제적 수준의 변화를 꾀함으로써 상위수준의 도식을 변화

② 반복되는 고정된 모드에서 떨어져서 다른모드로 전환하는 기술을 배우는 방법

: **알아차림 모드로 전환**하는 기술을 배우는 것

메타인지를 작동시키고 그러면 지혜가 나타난다.

: **탈중심화(decentering)**되어 **지금, 여기에 존재하는 것을 깊이 자각**하는 것. 사적 경험에 대하여 다르게 변화시키려는 노력을 중지하고 **원치 않는 것도 있는 그대로 환영하며 수용하는 방식**

불안한 마음이 어느정도인지 바라보고자한다면 불안에 휩싸이지 않고 불안을 바라볼 수 있다.

★출제예고-마음챙김★

MBSR(Mindfulness-Based Stress Reduction)

- 마음챙김에 기반한 스트레스 감소

- 1990년대 마음챙김에 기반한 스트레스 감소 프로그램 개발 **잔 카밧진 개발**
- 그 후 스트레스 관련 질병 환자의 치료에 적용하여 탁월한 효과가 있음을 밝히는 연구결과들이 축적됨
- 2000년대 MBSR을 기본으로 하는 수많은 치료프로그램이 개발됨 (MBCT(우울증), ACT(현대의 행동분석치료), DBT(경계선 성격장애 환자), MBEating(거식증) 등
- MBSR 프로그램: 8주에 걸쳐 총 30시간 지도, 학교의 수업처럼 프로그램화 되어 체계적으로 이수하여 익히는 명상법**

• MBSR구성

- 공식명상 : 보디스캔, 호흡명상, 정좌명상, 하타요가
- 비공식명상 : 먹기명상, 걷기명상, 자애명상, 용서명상
- 8주 훈련 후 공식명상 4가지 중 어느 하나, 또는 2가지 이상을 결합하여 45분 동안 일주일에 6일 정도 평소 꾸준히 실천해가도록 한다.

마음챙김(Mindfulness)

▶ 마음챙김(Mindfulness)이란?

- **지금(now), 이곳(her)**에 마음을 모아 깨어 있는 것.
- 몸, 느낌, 마음의 관찰
 - **지금 내 몸에는 어떤 감각이 일어나고 있는가?**
 - **지금 나는 무엇을 느끼고 있는가?**
 - **지금 나는 무슨 생각을 하고 있는가?**
- 마음챙김은 기술의 습득이 아니라, 깨어 살아가면서 지혜를 개발하는 훈련이다.

▶ 마음챙김 명상

- 불교 수행법의 하나로, **비판단적이고 의도적으로 주의를 현재에 기울이게 하는 자각훈련**
- 생각이나 **감정 또는 감각을 있는 그대로 수용하여 온전히 경험하는 것을 촉진**

▶ 마음챙김 명상에 작용하는 4가지 요소 ★

- **주의(attention)/ 알아차림(awareness)/ 이해(understanding)/ 자비(compassion)**
- 주의가 편안한 상태에서 안정적으로 지속되며, 의식은 가볍고 명쾌하고 이루어지고 있으며, 자기자신이나 삶에 대한 이해와 지혜가 자라나며, 친절감과 자비심이 인격 속에 스며든다.
- 위빠사나 명상의 싸띠(sati)에서 유래한 용어
 - sati란 산스크리트어의 '기억하다'를 어원으로 하는 용어
- 기억(memory), 재인(recognition), 의식(consiousness), 주목(interetness), 마음챙김(mindfulness)
 - '기억' = 이미 경험한 사실에 대한 마음의 작용 **현재까지 진행되는 것이다.**
 - '마음챙김' = 현재의 대상에 대한 마음의 작용 **이것을 빠져나와서 바라보는 것.**

- 한역 : 正念, 수의守意, 관觀 觀法 **염: 今心 지금의 마음**

- 영어 : 'mindfulness', 'bare intention', 'noting', 'awareness', 'observance', 'comprehension', 'attention'

- 우리말 번역 : 마음챙김 이외에 깨어있음, 주의깊음, 마음집중, 마음지킴, 알아차림, 수동적 주의집중

Mindfulness state

mindfulness는 변성의식상태가 아니다

무의식으로 가는 것이 아님. 무의식과 의식의 사이를 오락가락하면서 바라보는 것.

- 자신을 관찰하는 눈을 유지하면서, 내면에서 일어나는 것들을 깨달아가는 상태

↔Unconsciousness

- 무의식으로 들어가버리는 것은 완전히 변성의식 상태로, 최면효과 등을 기대할 수 있는 상태

Mindfulness- 7가지 태도와 행동

비판단, 수용, 인내, 애쓰지 않음, 놓아두기, 신뢰, 초심자의 마음

비판단: 자신은 비판하는 생각을 하지 않고, 그런 생각이 든더라도 그 역시 알아차리기

애쓰지 않음: 알아차리기 위해 애쓰지 않는다.

마음챙김 평가도구에서의 5요인

(FFMQ: Five Facet Mindfulness Questionnaire)

- 비자동성 nonreactivity
- 기술 Describing
- 관찰 observing
- 자각행위 Acting with awareness
- 비판단 Nonjudging of experience

비자동성: 내가 자동으로 반응하지 않는 것, 화가 나는 상황에서 화가 자동적으로 나는 것이 아니라 내가 화가나는구나~하고 받아들이는 것

의식상태에 따른 심리

- Ordinary consciousness(기본 의식): CBT
- Mindfulness state: MBSR, Hakomi therapy
- Unconsciousness(무의식): Hypnotherapy

• 마인드풀니스한 상태에서

- 사람의 심층에 들어있던 핵심신념(Core Belief)이 의식의 수면위로 떠오르게 됨.
- 의식 수면으로 떠오른 신념을 바라보고 그게 무엇인가 공부하고 그것을 이해하게 됨
- 이 과정에서 무의식의 협력을 얻는 게 매우 중요한데, 마인드풀니스 상태가 아니고서는 무의식의 협력을 얻을 수가 없다.

Mindfulness를 이용한 심리치료

종류	내용
MBSR	Mindfulness-Based Stress Reduction, 마음챙김에 기반한 스트레스 감소, 잔 카밧진, 1979년 메사추세츠주 립대
MBCT	Mindfulness-Based Cognitive Therapy, 알아차림인지치료 (우울삽화 재발방지)
ACT	Acceptance & Commitment Therapy, 수용전념치료
DBT	Dialectical Behavior Therapy, 변증법적 행동치료 (경계선 성격장애)
MB-EAT	Mindfulness-Based Eating Awareness Training, 마음챙김 기반 식이자각훈련
MBPM	Mindfulness-Based Pain Management, 마음챙김에 기반을 둔 통증관리

Mindfulness의 신경생물학적 기전

전 전두엽을 활성화시키는 것이 포인트

- 부교감-변연계 회로가 활성화, 교감신경의 활성이 감소
- 좌측 앞쪽 알파파 활성화 (긍정적 정서와 관련)
- 정서중추인 편도체 활동을 감소시키고, 긍정적 정서 유발하는 좌측 전전두피질 활성화 *top→down* 강화
- 우측 전 섬이랑(right anterior insula)와 해마(hippocampus) 회백질 농도가 더 큰 것 : 학습과 기억 과정, 정서조절, 자기 지시적 과정과 인식을 담당하는 뇌의 회백질 농도를 변화시키는 것과 관련이 있음이 입증
- Task-positive region의 활성화도 높이고 상대적으로 DMN(default mode network) 활성도를 낮춤
- 유전자 발현에도 영향 (면역관련 유전자 상향조절)

수용-전념치료(ACT) 읽어보라고하고 넘어감!

1) ACT와 고전적 인지행동치료와의 차이

- 개인의 경험(생각, 행동)의 형태를 바꾸는 것이 아니라 기능을 바꾸는 것
= 각 경험들이 관련되어 있는 맥락(경험하는 방식)을 바꿈!
- 전체적인 관점에서 개인의 가치를 구체화, 중요시한다. 개인이 선택한 목표와 가치에 따라 행동의 실효성을 기준으로 함.

2) ACT의 치료과정

- ① 현상황에 직면하기
: 이제까지 사용해온 통제 전략들을 알아차리고 이러한 전략이 효과없이 부적절하게 사용된 것임을 깨닫게 하는 것
- ② 통제와 경험회피(experimental avoidance)가 문제임을 깨닫기
: 통제하는 전략들(제거, 억제, 주의전환)이 사적인 경험들에 대해선 잘 작동X
- ③ 대안제시하기 : 기꺼이 경험하기=자발성(willingness)와 수용(acceptance)
: 지금-여기에서의 사적 경험을 비판단적이고 적극적으로 껴안는 것이며, 생각, 감정, 신체적 감각에 방어 없이 직접적으로 "노출(exposure)"하는 것
- ④ 인지적 탈융합(cognitive defusion)과 마음챙김(Being present)
: 생각이 말하는 대로가 아니라 생각을 생각으로 볼 수 있게 하는 기술
- ⑤ 맥락으로서 자기 - '자기초월적 의식'
: 심리적 내용들에 의해 위협 당하지 않는, 불변하는 자기가 있는 맥락!!!
: 자기와 사적 경험을 구별!!
- ⑥ 가치(value) 찾기
: 가치들을 영역별로 명료화하고 이를 실현할 수 있는 구체적인 목표와 구체적인 행동들을 기술하게 한다.
- ⑦ 전념(commitment) 행동
: 새로운 습관의 구축

정신치료의 공통적인 요소

- 정신치료는 솔직함, 정직 및 신뢰를 소중하게 생각한다는 것이다.
- 정신치료의 일차적인 초점은 모든 형태의 정서를 의식적인 깨달음을 통해 인지하고 통합시키는데 있다고 본다.
- 의식적인 깨달음과 함께 감정을 유발시키는 것이 증상의 감소와 개인적인 성장을 가져올 가능성이 가장 높다는 인식이 있다. 모든 형태의 치료들은 신경망의 통합에 그 초점

정신분석가로서의 나의 역할은 환자들이 자신의 잃어버린 전체성을 발견하고 정신세계를 강화시키도록 도와줌으로써 미래에 일어날 분열들에 저항할 수 있도록 해주는 것이다

-CG Jung-

정신치료는 수면아래로 가라앉아 의식화되지 못한 정서들이 (저항, 생존전략 등으로 인함) 자연스럽게 떠올라서 무의식이 의식화되어지는 것을 *mindfulness*로 알아차려서 인지와 통합되어 자아가 넓어지는 과정

신경과학적으로 본 정신치료의 의미

- ① 안전함과 지지적인 관계, 치료적 관계에서의 공감적 조율이 신경형성력의 최적의 생화학적 환경을 만듦
- ② 적절한 스트레스라고 부르는 상태에서 최적의 발달과 통합을 경험한다.
- ③ 정서를 견디고 조절할 수 있는 능력은 일생을 통해 뇌가 성장하는데 필수적. 정서의 조절이 정신치료의 효과 중에서 가장 중요한 것. 신경망의 통합
- ④ 치료자와 환자 사이에서 '함께 만들어가는 이야기'는 많은 신경망이 통합할 수 있는 지지적인 광범위한 기반을 제공

[3] 정신과적 응급

정의	환자가 자신의 생명을 위태롭게 하거나 (자살), 다른 사람의 생명을 위태롭게 하거나 (폭력), 생명의 위협을 받았거나 (재난, 사고, 강간 등), 또는 여러질병 (뇌장애, 정신병, 급성불안, PTSD, 물질 남용 등)으로, 환자가 극도의 흥분이나 혼란, 환각, 공황을 경험하여 즉각적인 처치가 필요할 때
주요 정신 질환	조현병, 급성정신병, 주요우울증장애, 양극성장애, 자살시도, 알코올사용장애, 약물남용 등의 물질관련장애

자살

개요 및 역할

- 가장 대표적인 정신과적 응급상황
- 전세계적으로 매일 1000명, 연간 50만명이 자살로 생을 마감
- 현재 자신이 지속적으로 겪고 있는 심한 고통이나 문제들로부터 벗어나기 위해 선택하는 여러 방법중 하나
- 주요 사망원인 중 사망률 4위 (2003년)
- 남자가 여자보다 2배 이상의 자살사망률
- 자살시도는 자살성공의 8~10배
- 자살시도를 하는 경우는 대개 수개월 이내에 다시 시도할 가능성이 매우 높다.
- 유색인<백인, 배우자有<배우자無, 천주교인<타종교인
- 계절적으로는 가을,겨울 < 봄,여름
- 자살의 가족력이 있는 경우 & 사회적으로 고립되는 경우에 자살률이 높아진다.
- 정신질환이 있을 경우가 없는 사람에 비해 3-12배 정도 자살률이 높다.

원인론

생물학적 원인	- 세로토닌 체계가 결핍. 충동조절 미흡 - 유전적 : 가족력, 쌍생아연구 / 조현병이나 양극성장애, 알코올 의존등이 유전관련성
심리학적 원인	- 자살은 양가감정이 합입된 사랑하는 대상에 대한 무의식적 공격성을 나타낸다. (프로이트) - 자살하려는 사람의 환상에서 정신역동 이해 (복수, 권력장악, 지배, 징벌, 용서, 희생, 탈출, 구원 등). 절망이나 낮은 자존감.
사회학적 원인	이기적 자살, 이타적 자살(eg 순교), 무통제적 자살(eg 경제공황) 이기적 자살: 개인이 속한 사회집단과 융합되지 못함. 과도한 자아의식과 이기주의로 개인과 사회가 단절 이타적 자살: 지나치게 사회집단과 융합되어 집단을 위해서 개인이 희생 무통제적 자살: 사회집단에서 와해되거나 차단되는 것(해고 등), 집단의 가치나 규범이 느슨해지는 공황적 상태
스트레스 취약성 모델	: 위험요인과 방어요인의 균형이 깨져서 위험요인 : 자살성향, 스트레스, 급성 트리거(이별, 상실, 갈등, 경제적 문제 등) 방어요인 : 긍정적, 지지적 가족, 대인관계, 적극성, 종교, 바람직한 생활, 습관 리소스

질병의 증상으로 본 자살행위

- 신체적 질병과 대단히 밀접한 관계.
- 원인 : 물질남용, 우울증, 정신분열증, 기타 정신장애 등
- 자살 실행한 사람의 95%가 실행당시 정신장애가 있었다는 보고 (우울증 80%, 정신분열증 10%, 치매나 섬망 5%)
- 우울증 말기보다 초기에. 회복기에 더 많이 위험(미래에 대한 희망없음이 중요한 원인) = 충동성과 관련
- 조현병 환자의 약 50%가 자살기도. 발병 후 수년 이내
- 알코올관련 장애 환자의 10-15% 자살. 남자 다수. 우울증 동반시 자살률 높음
- 반사회적 인격장애자 5%

자살 평가 및 위험인자

- 자살 위험 평가: 병력 청취, 정신상태 검사, **자살 의도나 계획에 대한 구체적 질문**
- 우울증상, 슬픔, 죄책감, 절망, 초조시 자살 위험 높음
- 자살 위험인자

- ✓ 45세 이상, 알코올 의존, 짜증, 격노, 난폭함
- ✓ 과거 자살 시도 경험, 남성
- ✓ 도움받기를 거절함
- ✓ 우울증 기간이 평소보다 길 때
- ✓ 과거 정신병 치료경험
- ✓ 최근의 상실 또는 이별
- ✓ 우울, 신체 건강의 상실
- ✓ 실직 또는 은퇴 독신

자살예방

- 자살자들 10명 중 8명은 자살 의도를 주위에 알린다.
- 죽고싶다거나 계획을 **구체적으로** 말하면 위험한 징후
- 자살하겠다고 환자가 갑자기 조용해지거나 침착해진다면 임박
- 자살 가능성이 의심된다면 반드시 **직접적이고 구체적으로 물어보아야함**
- 자살 위험성이 매우 높으면 입원 (폐쇄병동 → 양방 정신과 등 전문기관 refer)
- 사회적 지지체계 없거나
- 환자가 난폭하고 충동적
- 자살 계획이 뚜렷한 경우

자살가능성 의심환자에게 반드시 물어야할 질문 ★

- ① 이전에 자살에 대해서 생각해본 적이 있습니까?
- ② 지금까지 자살을 시도해본 적이 있습니까?
- ③ 현재에도 자살하고 싶은 마음이 있습니까?
- ④ 어떻게 자살할 것인가에 대해 구체적인 계획을 갖고 있습니까?
- ⑤ 만약 그렇다면, 구체적으로 그 계획을 말씀해 주시겠습니까?

자살경향성 및 자살 위험성 (Mini plus Suidality 척도)

번호		Yes/no	가중치	점수
1	지난1개월 동안 차라리 죽는 것이 낫다고 생각하든지 죽었으면 하고 바란 적이 있다		1	
2	자해하고 싶다		2	
3	자살생각		6	
4	자살계획		10	
5	자살시도		10	
6	평생동안 자살시도를 한번이라도 한 적이 있다.		4	
총합				

자살경향성 : 6개의 항목 중에서 최소한 1개의 항목 이상에서 예라고 응답한 경우
자살위험도

- ✓ 1-5점인 경우 : 자살위험도가 낮은 군
- ✓ 6-9점인 경우 : 자살위험도가 중등도인 군
- ✓ 10점 이상인 경우 : 자살위험도가 높은 군

자살위기중재의 핵심 3요소 ★

- 1) 공감적 의사소통
- 2) 자살방어인자 강화 **리소스, 죽지 말고 살아야할 이유**
- 3) 자살위험도 평가 및 중재

자살에 대한 구체적인 질문, 필요하면 정신과로 refer

그 외에 위험인자가 있는지 확인

응급위기대응

- 자살 위험성이 있다고 판단될 경우
- ☞ 보호자, 보호기관 등 연계하여 입원권유 및 권유결과 기록
- ☞ 거절시 거절에 대한 내용기록
- ☞ 자살사고는 있으나 계획이나 의지가 약할 경우에도 입원 혹은 입원가능 정신과진료 권유하고 결과 기록하여야

의사의 책무

- 환자에게 진료 중에 자살을 짐작할 만한 임상적 증후가 있었는지, 의사가 이러한 증후를 인지하고 대응하였는지에 대한 여부가 중요
- 법적으로 모든 자살을 예방할 수 없다는 것은 인정되나, 환자의 자살 가능성을 평가에 잘 평가하였는지 여부와 이와 관련한 치료계획이 존재하였는지 여부, 실제 진료에서 이러한 계획을 이행하였는지의 여부가 중요할 것으로 사료
- 관련 의료기록을 남겨두어야 함
- 우울증에서 자살이 다발하는 경우가 많으므로 환자가 복용중인 약이 있는지 확인해야함
- 환자는 의사와 라포 형성이 어느정도 된 뒤에 털어놓는 경우가 다반
- 의심된다면 확인이 필요

QPR for suicide prevention ★

- ✓Question
- ✓Persuade
- ✓Refer
- Ask a question, save a life!!

Question	“최근에 힘든 일이 있었나요?” / “너무 힘들어서 죽고 싶단 생각이 든 적이 있나요?” / “영원히 깨지 않았으면 좋겠다는 생각 한 적 있나요?” / “자살에 대해 생각하고 있나요?” 자살에 대한 생각이 있을 때 “어떤 방법으로 자살을 생각하였나요?”에 대한 대답이 있으면 = 위험상태
Persuade	문제의 경청, 충분한 관심. 자살은 문제가 아니라 해결책일 뿐이란 것을 기억.(환자들이 해결책으로 자살을 선택한다는 뜻) 어떤 식으로든 희망을 가지도록. “도움을 청하러 같이 갈까요?” / “도움을 받을 수 있는 곳을 알아볼 때까지, 자살하지 않겠다고 약속해 줄 수 있나요?” <u>자살하지마세요! 보다는 자살을 미룰 수 있겠냐고하기</u>
Refer	자살 시도자는 적극적인 도움요청을 못한다. 의료진이 좀 더 적극적이어야함 = 도움을 받을 수 있는 곳으로 갈 수 있게 진행시킨다.

자살에 대한 오해와 진실 ★

- 오해 : 누구도 자살을 막을 수 없다. 어쩔 수 없는 일이다.
- 👁️ **진실 : 적절한 도움을 받으면 다시는 자살 생각을 하지 않게 할 수 있다.**
- 오해 : 자살에 대한 언급을 직접적으로 하는 것은 그를 화나게 하고 자살 위기를 심화시킬 뿐이다.
- 👁️ **진실 : 불안을 낮춰주고 대화의 길을 터줌으로써 충동적 행동을 할 위험을 줄일 수 있다.**
- 오해 : 전문가만이 자살을 예방할 수 있다.
- 👁️ **진실 : 누구나 막을 수 있다**
- 오해 : 자살에 대해 이야기하는 사람들은 실제로는 자살하지 않는다.
- 👁️ **진실 : 자살을 실제로 하거나 자기파괴적 행동을 할 가능성이 높다**
- 오해 : 일단 사람들이 자살을 하기로 결심하면 아무도 그것을 막을 수 없다.
- 👁️ **진실 : 충동적일 경우 당시 5분 또는 1시간만 막아줘도 영영 막을 수 있다.**

자살 기도자의 치료

- ‘자살을 기도한 이후의 치료’와 ‘자살 예방’
- 자살기도자의 치료 목표

- 1) 살아있게 하는 것
- 2) 심리적 고통을 감소시켜 주는 것
- 3) 희망을 주는 것
- 4) 스트레스를 다룰 수 있는 방법을 습득토록 하는 것

- 동굴시야 (tunnel vision)
 - 인지적 융통성이 크게 저하되어 다양한 방법을 모색하지 못하고 자살만을 유일한 해결책으로 생각하는 경직된 사고방식을 벗어날 수 있게
 - 자살 예방 : 자살 가능성을 가진 사람을 미리 알아내는 일
- (과거의 자살 기도여부, 현재의 심리상태, 주변의 환경, 사회적 지지여부, 스트레스 수준, 우울증 병력 등)

자해

자해의 정의

- 자살에 가까운 자기 파괴의 형태
- 자신 또는 내면화된 대상을 벌하고자 하는 무의식적 욕구에서 생긴 공격적 충동
- 자살행동장애 suicidal behavior disorder 자살에 매우 가까운 자해
비자살 자해 nonsuicidal self-injury 자살이 아닌 자해

자살행동장애와 비자살 자해의 감별

☞ 행위에 자살 목적이 있었는지 여부로 구분

- 비자살 자해는 고통은 있으나 그것으로 사망에 이르지 않는 수준을 익혀 수준을 유지
- : 사용도구가 위험하거나 자해가 정기적이거나 인간관계가 폐쇄적일 경우 실제 자살시도 가능성 → 양방 정신과 refer
- 자해의 시도가 많을수록 자살 시도 가능성은 높아짐
- 구분이 명확하지 않으면 자살적 자해로 인식하는 것이 안전
- 자살적 자해인 경우 = 자살 시도와 마찬가지로 인식해야 함

자해에 대한 합리적 접근

- 자해와 자살은 같은게 아니다. 항상 의도에 대해 물어봐라
어떤 사람에게든 자해가 살아있는 것을 느끼게 하기도 함..
- 어떤 내담자에게는 자해가 자살을 방지하기 위한 전략으로 쓰일 수도 있다.
- “존중어린 호기심 respectful curiosity”를 보이고, 반응을 덜 하거나 과도한 반응을 하는 것을 삼간다.
- 어떤 내담자는 각각 자신만의 고유한 자해의 트리거와 이유가 있다. 이런 것들이 탐색되어야 한다.
- 어떤 행동에 대해 물어보는 것이 그 행동을 증가시키지 않는다. 자살, 해리, 정신 증에 대해 물어보는 것이 이런 행동을 증가시키지 않는다.

자해를 하는 이유

- 현실감을 느끼기 위해
- 감정적 무감각을 유도하기 위해
- 수치심을 다루기 위해 (자신이나 타인을 향한 분노)
- 유기에 대한 공황 / 애착 상실에 대한 공포를 대처하기 위해
- 만연한 자존감의 결핍(수치심, 무가치함)을 견디기 위해
- 희열같은 만족감을 제공(심리생물학적 중독반응사이클 **엔돌핀**)
- 트라우마 재연으로
- 내면의 ‘고통’을 외부로 재포커스 하기 위해, 고통을 신체의 한 부분에 국한시키기 위해
- 다른 사람으로부터 관심받고 안전을 보장받기 위해
- 자살을 방지하기 위해
- 타인이 상처주기 전에 자신을 상처주기 위해
- 내면에서 명령하는 목소리에 대한 반응으로
- 플래시백 전에 오는 불쾌감에 대한 반응으로
- 압도되는 감정에 대한 신체적 해결책으로 등등

자해의 트리거들

외적 트리거	관계적 상실이나 단절, 현재에 일어나는 사건들, 주기반응 (anniversary reactions, 기념일 반응), 환경에서 나타나는 트라우마 트리거
내적 트리거	감정의 활성화, 특히 수치심(견딜 수 없는 감정) 감각(감정/기억과 관련), 사고(“나는 나쁜 사람이야”, “아무도 나를 상관하지 않아”), 트라우마 기억/플래시백, 내면 혹은 외부 경험으로 파트들이 활성화되는 것

자해에 대한 치료적 개입

- 연민을 가지고 인정해주기 **무조건 부정하는 것 X**
- 감정조절 기술 / 정신화 기술(mentalizing skill)
- 트리거 파악
- 자기 연민 개발
- 내면 경험을 더 잘 견딜 수 있게
- 치료 속도 조절
- 인지적 오류를 바로잡기
- 사회적 지지를 증가시키고 고립을 감소시키기
- 관계적 기술을 향상시키고 가까워졌다 멀어지는 관계의 정상적인 변동을 더 잘 견디게 도와주기
- 해리 파트들과 작업하기

폭력

- 공격적 의도를 가지고 다른 사람이나 사물에 대해 해롭게 작용하는 행동
- 여자보다 남자에서 많음

- 심리적 원인 : 죽음의 본능이 타인에게 향하는 방어기제
- 발달적 원인 : 아동학대 등 가정내폭력, 대중매체
- 생물학적 원인 : 측두엽, 전두엽, 편도체손상, 남성호르몬, 세로토닌 등
- 관련정신질환 : 망상형 조현병, 경계성 또는 반사회적 인격장애, 인지장애, 치매
- 관련약물남용 : 알코올, 암페타민, 코카인, 마리화나, 환각제 및 안정제

- 사회경제적 수준이 낮을수록, 상대적 박탈감이나 좌절감이 클수록, 인구밀집지역일수록 빈도수 높음

- ✓의사나 다른 치료자의 안전을 확보하는 것이 가장 중요
- ✓경보장치설치
- ✓폭력행동에 이용될 수 있는 도구는 가급적 치워야함
- ✓환자와는 일정거리 두어야
- ✓위급상황발생이 우려될 때는 대피할 수 있는 비상구가 가까운 곳에 치료자가 자리를 잡도록

기타 응급상황★

공황발작	죽을 것 같은 공포, 심계항진, 진전, 호흡곤란, 흉통, 어지럼증 등 /신체질환 감별
섬망	의식의 저하(집중력, 인지기능 변화 등), 하루경과의 변화
조현병	환청, 망상 등으로 인한 공격성 증가. 혼미, 흥분 상태. 탈진 -> 약물진정
알코올 및 물질중독	알코올 금단증상/ 약물 중독 증상 ->입원
과호흡증후군	급성스트레스, 불안, 통증. 혈액 pH의 변화. 종이봉투 활용
신경성 식욕부진증	영양상태 및 내과적 합병증 심할 경우 입원
강간	정신과적 응급처치, 산과적 처치 필요. 환자의 절대적 안정 및 정서 상태 표현

기관연계

- 각 지역별 응급상황에 연락할 연락처를 확보
- 환자에게 연락처 제공
- 생명의 전화 / 한국자살예방협회 / 국립자살예방센터(1577-0199) / 보건복지부콜센터(129) / 112, 119 / 지역사회별상담센터